

PRIMERA PARTE

- 1 C Es un EPOC descompensado, que no responde y que está con una insuficiencia respiratoria global, severa, por lo que requiere apoyo ventilatorio. Por estar vigil y orientado, se prefiere la VM no invasiva, con BiPAP.
- 2 B Se sospecha una enfermedad de membrana hialina, por la edad gestacional, la que se diagnostica con radiografía de tórax.
- 3 D Es un millium sebáceo, que es un hallazgo normal del recién nacido.
- 4 A La endocarditis aguda se diagnostica principalmente con la clínica más la ecocardiografía y los hemocultivos.
- 5 C Es una insuficiencia aórtica clásica.
- 6 E Se sospecha un síndrome de Turner.
- 7 B Era un quiste del conducto tirogloso. De todas formas, el estudio del nódulo cervical, se inicia con la ecografía cervical.
- 8 C Los nódulos tiroideos mayores a 1 cm se puncionan con aguja fina, lo que da una muestra citológica, para hacer el diagnóstico.
- 9 A Parece un fibroadenoma, que se estudia y sigue con ecografía.
- 10 B Es una pregunta difícil, ya que el manejo de la NIE1 es muy variable. Se puede observar si la colposcopia es satisfactoria y el PAP es de bajo grado (en este caso además, se recomienda tipificar el VPH). Se debe tratar con crioterapia o ablación láser, si el PAP era de alto grado. Sinceramente no recuerdo bien si el PAP era de alto grado o no en la pregunta original.
- 11 C Es un pólipo biliar, de aspecto colesterolínico y menor a 10mm, por lo que se debe mantener en observación.
- 12 E No se entiende bien la pregunta, pero si se refiere al RR, pues es una medida de asociación, por lo que sería el criterio asociación. Sin embargo, también se entiende como que, al ser múltiples estudios, habría congruencia entre ellos.
- 13 C Es una hiperplasia suprarrenal congénita (por la edad), con una crisis adrenal (se ve por la hiponatremia, hiperkalemia y shock que no responde, así como por el dolor abdominal y vómitos, característicos). Además, está descompensado, probablemente por una infección (por la fiebre). Ante la simple sospecha, ya se debe administrar la hidrocortisona.
- 14 E Metrorragia, más dolor e hipertensión uterina sugiere un DPPNI. Además, la FCF en el límite bajo sugiere sufrimiento fetal, que también es propio del desprendimiento.
- 15 B Es una hiperplasia prostática benigna. La retención urinaria aguda es indicación absoluta de cirugía (primero se instala una sonda Foley y luego se opera). La hematuria en una ocasión y el residuo de 150 ml son indicaciones relativas (sobre 150 ml se opera). El APE elevado solo es indicación de biopsia. Es una pregunta discutible, pero sin duda la respuesta es esa.
- 16 C Es una fobia social clásica: ansiedad en situaciones en que será sometido al juicio público.

- 17 D La posición púdica es característica de la luxación posterior de cadera. La fractura, en cambio, tiene posición impúdica (abducción, rotación externa y acortamiento).
- 18 D Es un traumatismo renal (trauma lumbar más hematuria). Se estudia con el UroTAC, que tiene contraste endovenoso (que luego se elimina por vía urinaria). El pielotAC, que viene sin contraste, es para la litiasis.
- 19 A Se debe sospechar una tuberculosis. Se estudia con baciloscopías (más el cultivo). La radiografía hay que pedirla igual, pero las baciloscopías son la respuesta, ya que son las que hacen el diagnóstico de la tuberculosis.
- 20 B El diagnóstico es clínico y en la vida real no hay que pedir ningún examen y se debe proceder a la cesárea (la tinción de Tzank es la única inmediata). El gold standard históricamente ha sido el cultivo viral, pero la PCR lo ha desplazado actualmente, por ser más rápida y más sensible.
- 21 C Tiene un PTI agudo, pero por tener menos de 20.000 plaquetas, hay que indicarle corticoides. Si tiene más de 20.000 plaquetas, solo se observa. Si tuviese hemorragias graves (ej: HDA o hemorragia intracraneal), se debería dar IgG ev. Si fuera crónico: siempre se indican los corticoides y si fallan, se hace esplenectomía.
- 22 D Es una escarlatina y el diagnóstico es clínico. No hay que pedir ningún examen, por lo que esta pregunta está técnicamente mala. El cultivo faríngeo es el goldstandard, pero demora. El test pack tiene el resultado es inmediato y hay que iniciar antibióticos ahora (de hecho, hay que iniciarlos porque ya está hecho el diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico). Lo más razonable es simplificar la pregunta a ¿cuál es el examen de elección para la escarlatina? y responder cultivo.
- 23 E Por las relaciones sexuales puede ser sinusorragia, que es la causa más frecuente de genitorragia durante el embarazo y que suele ser autolimitada y sin visualización de sangre saliendo por el OCE. De todos modos, se debe hacer una ecografía obstétrica, para descartar placenta previa. No tiene clínica de desprendimiento.
- 24 A Por llevar dos semanas, sospechar Mycoplasma. También por el compromiso intersticial. El moxifloxacino sí lo cubre, pero su espectro es muy amplio: cubre también anaerobios. El levofloxacino sí habría sido una respuesta correcta. Todos los macrólidos lo cubren bien y son de elección en los niños, que no pueden usar quinolonas y también en los adultos, en particular la azitromicina, que se toma por menos tiempo (5 días, vs. 14 de la claritromicina o eritromicina).
- 25 B Es un síndrome neuroléptico maligno clásico: se inicia o aumenta la dosis de un neuroléptico (sinónimo de antipsicótico) y evoluciona con la triada de rigidez, hipertermia y compromiso de conciencia.
- 26 B La velocidad con la que se notifica considera la gravedad de la enfermedad (letalidad), la contagiosidad de la misma. La idea de notificar es que la autoridad sanitaria pueda intervenir y controlar la propagación de la misma. En general solo se notifican enfermedades graves y que son infrecuentes y mientras más graves y contagiosas, se notifican más rápido.
- 27 A Es una sinusitis aguda. Por el tiempo de evolución es probablemente viral y no requiere sino tratamiento sintomático. Sin embargo, no aparecía dentro de las alternativas y lo

que se pregunta entonces es el tratamiento de la sinusitis bacteriana aguda, que de primera línea es con amoxicilina. Los descongestionantes tópicos, no son muy indicados, ya que tienen efectos adversos y no solucionan los demás síntomas.

28 C Faltaba información y no era posible ver bien la imagen. Podría ser una dermatitis de contacto alérgica, porque era en relación a un aro y excedía la zona de contacto, pero las lesiones en la cara no calzaban del todo. La visualización de costras mielicéricas es muy sugerente de impétigo (piodermatitis superficial), pero también puede verse en la dermatitis de contacto y el cuadro es clásico de esta enfermedad. No puede ser celulitis, porque no hay tejido celular subcutáneo en la oreja.

29 B Es un herpes genital clásico.

30 B Es una pregunta muy discutible, pero dado el diagnóstico de deshidratación hipertónica, con marcada hipernatremia e hipoalbuminemia, está relativamente contraindicado el suero fisiológico (la evidencia no soporta esta recomendación, pero lo habitual es que se crea que el SF puede agravar la hipernatremia). Podría iniciarse suero glucosalino isosmolar, pero no aparece en las opciones. Se pregunta el primer suero a administrar y el suero glucosado parece la única opción aceptable para la hipernatremia, ya que es hipotónico, pero no corrige la volemia y el paciente está shockeado. Sin embargo, también está la afirmación: “se corrige primero la volemia y luego, nos preocupamos de los electrolitos” y en ese caso sería correcto el SF, ya que con él se logrará corregir la volemia (con SF o Ringer) y luego corregir la natremia (con suero glucosado). No queda clara cuál era la respuesta correcta, pero lo más probable es que sea el SF.

31 C Por estar histerectomizada, debe recibir estrógeno solo y por ser dislipidémica, debe ser por vía transdérmica. Recordar que lo habitual es dar estrógenos más progestágenos, para evitar el riesgo de cáncer de endometrio, pero con la histerectomía, ya no existe el riesgo de dicho cáncer y bastan los estrógenos.

32 A Tiene un embarazo ectópico no complicado (aún), con contraindicación de metotrexato (más de 4 cm y más de 5.000 de HCG), por lo que debe tratarse con laparoscopia (tiene menos riesgo de la laparotomía). La laparotomía se usa en los casos en que se rompe.

33 C La hiperplasia atípica se trata con histerectomía. Si bien la paciente es nulípara, a los 46 años es improbable que se le indique un tratamiento más conservador, ya que probablemente no tendrá más hijos. De todos modos, en la vida real, se debe consultar la opinión de la paciente, ya que si sus deseos de fertilidad son importantes, se puede hacer una hormonoterapia con progestágenos y reevaluar con biopsia endometrial. La hiperplasia endometrial simple, en cambio, se trata con progestágenos.

34 D Es un coqueluche clásico: tos en accesos, precedido por cuadro catarral y linfocitosis en el hemograma.

35 D Parecía una trombosis de la vena central, pero no aparece en las opciones. Por tener DPAR sugiere un desprendimiento de retina, pero le falta tener fotopsias o entopsias que antecedan. Así, dados los antecedentes, lo más probable es la neuropatía óptica isquémica, que puede presentarse de esta forma y tener estos antecedentes. No puede ser una neuritis óptica, porque esta no es súbita, sino que aparece en varias horas.

- 36 C La clínica es de leucemia aguda. En la práctica es imposible diferenciar una leucemia mieloide aguda de una linfática aguda solo por la clínica, pero las adenopatías y la edad (joven) sugieren más una leucemia linfática aguda.
- 37 B Tiene desaceleraciones variables complejas, que son MEFI II si vienen con buena variabilidad, por lo que se debe reanimar intrauterinamente y luego interrumpir por la vía más expedita, que en este caso es cesárea, porque no se dan todos los requisitos para hacer un fórceps (10 cm de dilatación, espinas +2 o tercer plano de Hodge, cefálica y membranas rotas, con episiotomía amplia). Debe quedar claro que la primera medida siempre es hacer un tacto vaginal y si el registro es sospechoso (MEFI II) u ominoso (MEFI III), además se debe realizar la reanimación intrauterina (Lateralizar, O₂ y suspender la oxitocina, si es que la tiene); y solo en caso de que no responda en 30 minutos, se debe interrumpir por la vía más expedita. La única excepción es la bradicardia mantenida, que si dura más de 10 minutos o no se recupera luego de 2 minutos, se debe interrumpir de inmediato. Sin embargo, en las opciones no está reanimar, por lo que se asume que preguntan la interrupción.
- 38 C Recordar que la principal causa de falta de respuesta en los esquizofrénicos es la mala adherencia a tratamiento. En estos casos, si no tuviese una red de apoyo que ayude a asegurarse que cumpla el tratamiento, se debe evaluar la necesidad de cambiar el tratamiento de vía oral a intramuscular, de depósito.
- 39 D La clínica es de una otitis media crónica, cuyo diagnóstico es mediante otoscopia (ve una perforación timpánica, con cambios inflamatorios). Además, cualquier otro diagnóstico que hubiesen pensado, igualmente deberían haber empezado con un buen examen físico, que incluya la otoscopia.
- 40 A Es el cuadro clásico de la estenosis mitral. Recomendación: leer y aprender el resumen de semiología cardíaca.
- 41 B Si bien la foto no se ve muy bien, la clínica es sugerente de una fractura de cadera y la radiografía muestra una fractura de cuello femoral desplazada. Por tener menos de 65 años, se hace osteosíntesis con un tornillo (DHS en fracturas intertrocantericas y tornillo canulado en las de cuello) y no la prótesis (que solo se hace en el caso de que cumpla con 3 criterios simultáneos: 1. adulto mayor con fractura de 2. cuello y 3. desplazada).
- 42 A Es un trastorno delirante crónico, con un delirio de daño clásico. No es un trastorno de personalidad, porque está psicótico y los trastornos de personalidad solo traen malas relaciones interpersonales, pero no se pierde el juicio de realidad. No tiene los demás síntomas de la esquizofrenia y por la edad es improbable.
- 43 D Por ser una anemia microcítica (VCM menor a 80) lo más probable es que sea ferropénica. Si hubiese sido normocítica, la sospecha hubiese sido enfermedades crónicas, en particular por la edad.
- 44 C El EKG tiene signos de hipertrofia ventricular y toda la clínica es concordante con una cardiopatía hipertensiva: hipertenso de larga data, mal controlado, con signos de HTVI en el EKG. Además, por la edad es improbable que sea una MCPHT.
- 45 A Adulto mayor que se desorienta = delirium o síndrome confusional agudo.

46 C Tiene un parto prematuro menor a 34 semanas, por lo que se debe frenar (con nifedipino) y además, se deben dar corticoides para maduración pulmonar. Antes del tacto, debió haberse hecho una Ecografía transvaginal, para medir el cuello.

47 D La vancomicina es el tratamiento de elección para: 1. Estafilococo resistente a meticilina, 2. Neumococo resistente a penicilina y 3. Enterococo resistente a ampicilina. Esto porque los tres tienen resistencia por medio de mutaciones de las PBP (penicilin binding protein), lo que los hace resistentes a todos los betalactámicos. Además, sirve para el Clostridium difficile resistente a metronidazol.

48 C Paranoide = desconfianza. Límitrofe = autoagresión, agresividad, inestabilidad emocional e impulsibilidad. Esquizoide: desinterés por los demás y apatía. Evitativo = autoestima baja, gran timidez, ansiedad en las situaciones en que se expone al rechazo. Antisocial = delincuente, sin empatía, ni consideración sobre el sufrimiento ajeno.

49 B La Seremi de Salud es la autoridad sanitaria y por tanto quien da las autorizaciones sanitarias.

50 B Es un exudado pleural mononuclear y por tanto se debe biopsiar, de primera línea, mediante biopsias percutáneas. Una forma nueva de hacer la biopsia es la videotoracoscopia, que tiene más sensibilidad y que se hace cuando las biopsias percutáneas resultan negativas (en este caso solo salía la VAT, así que esa es la respuesta).

51 A Dado que hay dilatación del colédoco (mayor a 7 mm), lo más probable es que sea una coledocolitiasis, la que generalmente cursa con dolor, pero puede hacerlo solo con ictericia (igual que el cáncer). Las colestasias farmacológicas suelen producirse a nivel hepático y no a nivel del colédoco. El Síndrome de Mirizzi es la obstrucción del colédoco por un cálculo ubicado en la vesícula, el que se habría visto en la ecografía.

52 B Es un síndrome de discontinuación de ISRS clásico.

53 B Es una medida clásica de prevención primaria, de tipo prevención específica.

54 C La maniobra de McRoberts es el manejo de primera línea en la distocia de hombros, ya que tiene 90% de éxito y bajísima morbilidad.

55 A Es un cuerpo lúteo hemorrágico clásico: dolor anexial en el día 18 a 21, con signos peritoneales. Además la ecografía descrita es característica.

56 D Es un absceso periamigdalino clásico: odinofagia, trismus y abombamiento del pilar faríngeo.

57 D Tiene un derrame pleural, que debe ser puncionado, para analizar el líquido.

58 D Es una pregunta discutible, ya que no indican el nivel de alergia a la penicilina. En general, la alergia a la penicilina no contraindica a las cefalosporinas y la cefazolina es más potente antibiótico que la clindamicina. Sin embargo, si es que ha habido un shock anafiláctico o angioedema, sí se contraindican las cefalosporinas. La clindamicina es una buena opción y no tiene ninguna contraindicación por la alergia, por lo que se asume que es la respuesta correcta.

59 E La clásica causa de orquiepididimitis es la infección por clamidia y luego gonorrea. Sin embargo, la E. Coli es la causa más frecuente cuando no hay infección de transmisión sexual y es especialmente frecuente en adultos mayores. En este caso, si le

creíamos que tenía pareja única, la respuesta probablemente era E. Coli. Además, en el Eunacom no es recomendable desconfiar de los pacientes ni de los enunciados.

60 D Lo primero a descartar, siempre es la hepatitis A, con IgM-VHA. Si no, se busca la B, con Ag-VHBs. Además, que al ir al Caribe o a donde sea, se expone a comidas contaminadas, con mayor frecuencia que a contactos sexuales de riesgo.

61 D La causa más frecuente de diarrea crónica en el paciente VIH es el *Cryptosporidium* sp. Además, suele presentarse con niveles de CD4 menores a 50 por mm³. No se debe confundir con el criptococo, que produce meningitis (y neumonía).

62 C Por tener una creatinina mayor a 1,4 mg/dl, está indicado el inicio de la insulina y además se debe evaluar la necesidad de suspender el hipoglicemiante.

63 B Es una polineuropatía clásica (ver resumen de semiología neurológica).

64 D Tiene un síndrome de malabsorción: diarrea, baja de peso, probable lentería y signos carenciales (anemia ferropénica), lo que orienta a enfermedad celíaca. No tiene hematoquezia, fiebre ni otras cosas que orienten a enfermedad inflamatoria intestinal.

65 A Tiene un bloqueo AV de segundo grado, Mobitz I (PR se va a largando hasta no conducir), por lo que se debe observar

66 C Es una artritis reumatoide juvenil o artritis juvenil idiopática, que se trata con AINES, de elección el naproxeno. Tiene buen pronóstico.

67 C Es un LES clásico, con las úlceras orales y el compromiso renal (mujer joven orienta).

68 D Se sospecha una diverticulitis aguda, la que se estudia con TAC de abdomen y pelvis.

69 A Ya se erradicó y se confirmó la erradicación con la EDA (por ser gástrica; porque erradicación en la duodenal se confirma con antígeno en deposiciones). Ya no es necesario tratamiento alguno. El tratamiento con omeprazol solo dura 4 a 6 semanas en la UGD. Solo en el RGE es a permanencia.

70 A Tiene una depresión en el adulto mayor (GDS mayor a 3/10: escala de depresión geriátrica). Se trata con ISRS, como elección (en especial sertralina y citalopram/escitalopram). Están contraindicados los tricíclicos en el adulto mayor.

71 A Tiene hipercortisolismo confirmado con el cortisol libre urinario de 24 horas. La ACTH muy elevada hace probable una causa hipofisiaria (tumor productor de ACTH), es decir, enfermedad de Cushing. Sí podría ser un síndrome de ACTH ectópico, pero le faltan datos que sugieran cáncer y es muy joven, como para tener un cáncer de células pequeñas pulmonar.

72 B Tanto por el temblor, como por las alucinaciones, como especialmente por el deterioro asociado a antipsicóticos, es una demencia por Cuerpos de Lewy.

73 D Es una pericarditis aguda clásica (paciente joven con dolor torácico, que aumenta con la inspiración y con supradesnivel del ST difuso en las precordiales) que se trata con ibuprofeno o con otro AINE en dosis altas por vía oral. La B hubiese sido la correcta, si hubiese sido un síndrome coronario agudo (con factores de riesgo y clínica sugerente, que no aumente con la inspiración). La D hubiese sido la correcta si en el electrocardiograma hubiese

salido el patrón S1Q3T3, por sospecha de TEP. El dímero D no está indicado a menos que haya una baja sospecha de TEP.

74 C Tiene un síndrome de HTEC (cefalea matinal y vómitos) más convulsiones, lo que sugiere fuertemente un tumor cerebral.

75 A Es un SOP clásico: oligomenorrea más hiperandrogenismo (acné). En los exámenes suele elevarse la testosterona, estradiol, LH e insulina. En cambio, disminuye la progesterona, por la anovulación.

76 A La sospecha es una cetoacidosis diabética (clínicamente podría haber sido una hipoglicemia también, pero el HGT elevado la descarta). La primera medida ante la CAD y el Sd. HGHO es dar SF ev. No se puede administrar insulina ni potasio, mientras no se cuente con la potasemia (si está baja, contraindica a la insulina; si está elevada, contraindica el potasio).

77 E Es una PAM clásica: adulto mayor con GNRP y patrón pauciinmune.

78 B Todos los anticuerpos contra la hepatitis C están negativos, por lo que no puede ser una hepatitis C. Tiene el antígeno de superficie negativo, por lo que no tiene hepatitis B. Tiene la IgM anticore negativa, por lo que no puede tener una hepatitis B aguda (en periodo de ventana podría tener el antígeno de superficie negativo). Tiene la IgG antisuperficie positiva, por lo que está protegido de la hepatitis B, ya sea porque está vacunado o porque ya se enfermó y luego sanó. Como la IgG anticore está positiva estuvo expuesto al virus y como ya sabemos que no cronificó (tiene el antígeno de superficie negativo), la única opción es que se enfermó y luego sanó.

79 E La sospecha es una diabetes insípida (síndrome polidipsico poliúrico, sin elevación de la glicemia), la que se estudia con el test de la sed, que incluye osmolaridades y sodios plasmáticos y urinarios, basales y post-privación de agua.ç

80 E La postración es FR para TEP. La clínica súbita con desaturación sugiere TEP. El EKG muestra taquicardia sinusal, un patrón S1Q3T3 (onda S mayor a R en DI, más presencia de onda Q y onda T invertida en DIII).

81 E Es un tumor complejo, en una mujer postmenopáusica. Se sospecha cáncer de ovario. El Ca-125 está elevado (mayor a 35). La biopsia es siempre quirúrgica y no por punción.

82 E La sospecha es un exantema súbito, por VH6 (fiebre muy alta, en un lactante de 6 a 18 meses, que desaparece y da paso a aparición de un exantema papular generalizado). La historia de la ITU es solo un distractor, ya que apenas tiene 10 leucocitos por campo, que puede ser normal, en especial si tiene fiebre alta.

83 B La bilirrubina mayor a 20 (afectación de las manos) hace pensar en una causa patológica, aunque haya empezado el segundo día de vida. Como tiene anemia (hematocrito menor a 45%) y la hiperbilirrubinemia es de predominio indirecto, es compatible con hemólisis y además, probablemente necesitará doble fototerapia más exanguíneo-transfusión (por la gravedad). Dado que la madre es Rh+, no puede ser por incompatibilidad Rh. Al ser O la madre, puede hemolizar al niño A. Si la madre hubiese sido Rh-, la respuesta habría sido incompatibilidad Rh, dado que era su segundo parto.

84 A Las displasias glandulares se estudia en el siguiente orden: 1. Pedir colposcopia + Curetaje endocervical y biopsias. Si sale normal: 2. Biopsia de endometrio.

85 E Es una procidencia de cordón umbilical clásica: se produce sufrimiento fetal agudo, luego de romperse las membranas, sin metrorragia. La rotura de vasa previa es igual, pero con metrorragia. La rotura uterina tiene antecedente de cesárea previa, con metrorragia durante el parto, contracciones dolorosas que desaparecen y aparición de sufrimiento fetal. El desprendimiento de placenta tiene contracciones dolorosas, metrorragia, sufrimiento fetal y útero hipertónico. La placenta previa no tiene sufrimiento fetal y tiene metrorragia.

86 E La sospecha es una sepsis neonatal (rechazo alimentario, problemas de termorregulación e hipotonía). La mera sospecha es suficiente para pedirle todos los exámenes, en busca de un foco infeccioso, incluyendo la punción lumbar e iniciar los antibióticos de amplio espectro, por vía endovenosa (ampicilina + cefotaximo).

87 A Tiene una preclamsia diagnosticada: SHE mayor a 20 semanas, con proteinuria positiva (mayor a 300 mg/día). El SHE se diagnosticó con la semihospitalización con PA mayores o iguales a 140/90 mmHg. Se debe hospitalizar (todas las preclamsias), solicitar exámenes de severidad (hemograma, tiempos de coagulación, función renal, pruebas hepáticas, LDH, ácido úrico), solicitar exámenes de bienestar fetal (Doppler fetal, perfil biofísico y ecografía). Además, se debe iniciar la alfametildopa (por tener PA mayor o igual a 150/100 mmHg). Los corticoides se indican por tener menos de 34 semanas (y más de 24).

88 D Es una atresia esofágica clásica: sialorrea, imposibilidad de tragar y dificultad respiratoria (porque aspira las secreciones y saliva y porque puede haber una fístula traqueoesofágica u otra malformación traqueal). La hernia diafragmática tiene distrés respiratorio (por hipoplasia pulmonar), abdomen excavado y RHA en el tórax. La atresia duodenal tiene vómitos explosivos, postprandiales, desde el nacimiento. El botulismo tiene una tetraparesia flácida y arrefléctica (al igual que el Guillain Barré, pero afecta a lactantes o a más de una persona).

89 D Es un cuerpo extraño vaginal clásico: metrorragia y leucorrea maloliente. En general son por papel higiénico en sobre el himen y son muy frecuentes en niñas. El himen imperforado produce amenorrea primaria, más dolor abdominal y eventualmente masa abdominal (por el útero aumentado de tamaño). El abuso sexual sí puede tener la clínica del caso, pero es más raro y tiene otras cosas, como actitud sexualizada de la niña u otras alteraciones psicológicas (se sospecharía si no hay cuerpo extraño). El cáncer vulvovaginal afecta a adultas y se caracteriza por prurito vaginal y luego genitorragia, más adenopatías inguinales.

90 C Las indicaciones de profilaxis son 1. Parto menor a 37 semanas, 2. Sepsis previa en otro hijo, 3. Urocultivo positivo para SGB (estas tres primeras, son indicaciones absolutas, independiente de si se hizo o no el cultivo perineal para SGB), 4. Cultivo perineal positivo para SGB, 5. Fiebre materna y 6. Rotura prematura de membranas mayor a 18 horas (estas últimas dos, solo si es que no se hizo el cultivo).